

Cocher la ou les propositions exactes

(Durées : 1h 10min)

- 1) Pour doser un antigène « X » par une technique immuno-enzymatique par compétition, On peut avoir besoin de :
 - A. Spectrophotomètre.
 - B. Des Anticorps anti-X marqués par une enzyme.
 - C. Des solutions étalons contenant des concentrations connues d'Ac anti-X.
 - D. Des Anticorps anti-X fixés sur la microplaque.
 - E. Des antigènes X marqués par une enzyme.
- 2) Le système Streptavidine- Biotine :
 - A. Augmente la sensibilité des techniques d'Immunofluorescence.
 - B. La Streptavidine est une vitamine et la biotine est une protéine microbienne.
 - C. La Streptavidine peut fixer 4 molécules de biotine.
 - D. On marque l'Ac ou l'Ag avec la biotine et on couple l'enzyme avec la streptavidine.
 - E. Est un système d'amplification du signal des techniques immuno-enzymatiques.
- 3) L'Hypersensibilité :
 - A. Peut être allergique ou non allergique.
 - B. Sont des signes cliniques objectivement reproductibles.
 - C. Quand elle est allergique le mécanisme peut être non immunologique.
 - D. L'hypersensibilité allergique est médiée uniquement par les IgE.
 - E. L'Hypersensibilité Allergique atopique peut être médiée par les IgG.
- 4) Dans l'hypersensibilité type I :
 - A. Le récepteur RFc ϵ 1 est composé de 4 chaînes polypeptidiques.
 - B. Les cellules TH2 sécrètent IL-4 et IL-13.
 - C. L'activation des mastocytes a lieu lors de la phase de sensibilisation.
 - D. L'activation déclenche deux types de réponses dans le mastocyte.
 - E. La libération de médiateurs préformés tels que l'histamine
- 5) Dans la réaction de type II, quel est l'effet des anticorps anti-récepteurs sur les cellules cibles ?
 - A. Effet antagoniste des anti-IgG sur les récepteurs de l'acétylcholine dans la Myasthénie
 - B. Activation de la prolifération cellulaire
 - C. Effet agoniste des anti-IgG sur les récepteurs de la TSH dans Maladie de Basedow
 - D. Déclenchement de l'inflammation
 - E. Toutes les réponses sont justes
- 6) L'immunofixation :
 - A. Permet de mettre en évidence un composant monoclonal.
 - B. Ne permet pas de mettre en évidence un composant monoclonal.
 - C. Permet de comparer les protéines sériques d'un patient avec un sérum témoin.
 - D. Ne permet pas de comparer les protéines sériques d'un patient avec un sérum témoin.
 - E. Contrairement à l'immunoélectrophorèse, elle est réalisée en un seul temps.
- 7) Le Mancini qualitatif :
 - A. Nécessite l'utilisation d'une courbe d'étalonnage.
 - B. Ne nécessite pas l'utilisation d'une courbe d'étalonnage.
 - C. Nécessite toujours l'incorporation de l'anticorps dans la gélose.
 - D. Ne nécessite pas toujours l'incorporation de l'anticorps dans la gélose.
 - E. Utilise comme le Laurell un champ électrique.
- 8) Dans la dermatite de contact allergique, le TNF- α intervient :
 - A. Au cours de la phase de sensibilisation
 - B. Au cours de la phase de déclenchement
 - C. Dans la différenciation des TCD4+ en Th1
 - D. Dans l'activation des macrophages
 - E. Dans l'activation des LT cytotoxiques
- 9) Concernant l'incompatibilité fœto-maternelle dans le système Rhésus
 - A. Elle survient chez une mère Rh- portant un fœtus Rh+
 - B. Le Coombs direct permet de détecter la présence d'anticorps dirigés contre les GR maternels dans le sang du nv-né

- C. Dans le Coombs indirect, un résultat positif indique que la mère a des Ac anti-Rh, augmentant le risque de MHNN
 D. Peut provoquer une hyperbilirubinémie chez le nouveau-né
 E. Les IgG anti-Rh passent à travers le placenta, entraînant une érythroblastose fœtale.
- 10) Les anticorps anti-Sm :
- A. Sont dirigés contre des antigènes nucléaires.
 - B. Sont dirigés contre des antigènes cytoplasmiques.
 - C. Peuvent être retrouvés dans le lupus érythémateux disséminé.
 - D. Ne sont jamais retrouvés dans le lupus érythémateux disséminé.
 - E. Sont des anticorps non spécifiques d'organes.
- 11) Les anticorps anti-globules rouges :
- A. Entraînent une anémie hémolytique.
 - B. Sont mis en évidence uniquement par le test de Coombs direct.
 - C. Sont mis en évidence uniquement par le test de Coombs indirect.
 - D. Peuvent être mis en évidence par les tests de Coombs direct et indirect.
 - E. Peuvent être retrouvés dans le lupus érythémateux disséminé.
- 12) Les techniques de chimiluminescence :
- A. Produisent une fluorescence suite à une réaction chimique.
 - B. Le prototype est le test Farr.
 - C. L'émission lumineuse peut provenir d'une molécule transformée par une enzyme.
 - D. Se caractérisent uniquement par un spectre d'émission.
 - E. La lecture se fait par un spectrophotomètre.
- 13) L'Anaphylaxie :
- A. Est une Réaction d'hypersensibilité systémique sévère.
 - B. Le traitement consiste en l'administration rapide d'Adrénaline.
 - C. En cas d'atteinte hémodynamique on parle de choc anaphylactique.
 - D. L'Allergène est toujours injectable.
 - E. Est une réaction d'Hypersensibilité type II.
- 14) Ces antigènes peuvent donner des réactions retardées granulomateuses :
- A. Dérivés microbiens
 - B. Germes
 - C. Allo-antigènes
 - D. Métaux
 - E. Particules inertes
- 15) L'objectif de l'utilisation de l'intradermoréaction comme outil diagnostique est :
- A. L'induction d'une réponse immunitaire primaire
 - B. La désensibilisation vis-à-vis d'un antigène donné
 - C. La réactivation des lymphocytes mémoires
 - D. La détection des sujets pré-sensibilisés vis-à-vis de l'antigène utilisé
 - E. La détection de l'allergène causal
- 16) Les facteurs qui influencent le lieu de dépôt des complexes immuns sont :
- A. Leur taille
 - B. Leur charge électrique
 - C. L'inflammation
 - D. Leur quantité
 - E. Toutes les réponses sont justes
- 17) La réaction d'agglutination active indirecte:
- A. L'Ag est particulaire et fait partie intégrante de la particule.
 - B. L'Ag est soluble et rendu particulaire par sa fixation sur une particule.
 - C. L'Ac est agglutinant.
 - D. L'Ac est précipitant est rendu agglutinant par sa fixation sur une particule.
 - E. Est appelée également test direct à l'antiglobuline.
- 18) L'épreuve de Beth Vincent :
- A. Est aussi appelée épreuve globulaire directe.
 - B. Est aussi appelée épreuve globulaire indirecte.
 - C. Permet de tester les globules rouges d'un sujet vis-à-vis d'anticorps sériques connus.
 - D. Permet de tester le sérum d'un sujet vis-à-vis de globules rouges connus.
 - E. Est appelée également épreuve de Simonin.
- 19) Les anticorps monoclonaux chimériques :
- A. Sont constitués d'une partie constante humaine et d'une partie variable murine.
 - B. Sont constitués d'une partie constante murine et d'une partie variable humaine.
 - C. Sont très immunogènes.

- D. Sont peu immunogènes.
E. Ne sont pas immunogènes.
- 20) L'inflammation dans l'HS de type III est le résultat de l'activation :
A. Du système du complément
B. Des macrophages
C. Des polynucléaires neutrophiles
D. Des polynucléaires éosinophiles
E. Des plaquettes
- 21) Pour donner des réactions de type Arthus, l'antigène doit :
A. Traverser l'épiderme
B. Se coupler aux antigènes endogènes
C. Passer dans la circulation sanguine
D. Rester dans le site d'introduction
E. Stimuler une réponse humorale spécifique à IgG
- 22) Les anticorps anti-récepteur de la TSH :
A. Sont des anticorps antithyroïdiens.
B. Ne sont pas des anticorps antithyroïdiens.
C. Sont spécifiques d'organes.
D. Ne sont pas spécifiques d'organes.
E. Ne sont jamais retrouvés dans le basedow.
- 23) La sélection positive :
A. Concerne uniquement les lymphocytes T.
B. Concerne uniquement les lymphocytes B.
C. Concerne les lymphocytes T et B.
D. A lieu au niveau des organes lymphoïdes centraux.
E. A lieu au niveau des organes lymphoïdes périphériques.
- 24) Les vaccins :
A. Font partie de l'immunothérapie active.
B. Font partie de l'immunothérapie passive.
C. Sont utilisés uniquement à visée prophylactique.
D. Peuvent être utilisés à visée thérapeutique.
E. Procurent un effet rapide mais éphémère.
- 25) La présence d'un clone plasmocytaire malin est détectée dans la moelle osseuse de patients atteints de :
A. La maladie de Kahler
B. Les MGUS-non IgM
C. La maladie de Waldenström
D. Le myélome indolent
E. Les maladies de chaîne lourde
- 26) La mise en évidence de l'IgM monoclonale dans le sérum :
A. Permet d'éliminer le diagnostic d'une maladie de Kahler
B. Est suffisante pour poser le diagnostic d'une maladie de Waldenström
C. Se traduit par l'apparition d'une ligne supplémentaire à l'immunosélecton
D. Nécessite l'utilisation d'une technique électrophorétique couplée à une technique d'immuno-précipitation
E. N'est pas nécessaire si le clone lymphoplasmocytaire est mis en évidence sur une biopsie médullaire
- 27) L'immunoglobulinopathie la moins fréquente parmi celles citées ci-dessous :
A. Myélome multiple
B. MGUS-IgM
C. MGUS-non IgM
D. Maladie de Waldenström
E. Maladie des chaînes lourdes alpha
- 28) Le syndrome de DI GEORGE est :
A. Un déficit qui touche principalement l'immunité humorale.
B. Due à une mutation d'un gène situé sur le chromosome X.
C. Un déficit immunitaire combiné.
D. Un déficit T- B- NK-.
E. Un déficit dont le traitement est basé sur l'injection d'immunoglobulines polyvalentes.
- 29) Le déficit en BTK est suspecté devant :
A. Un malade de sexe féminin.
B. La présence d'infection à répétition de localisation muqueuses.
C. La présence d'une hypergammaglobulinémie à l'électrophorèse des protéines sériques.
D. Un nombre normal des lymphocytes B au niveau de la circulation sanguine.
E. L'apparition d'infections à répétition dès les premières semaines après la naissance.
- 30) Parmi les moyens utilisés pour explorer un déficit immunitaire, on peut citer :
A. L'électrophorèse des protéines sériques.
B. Le dosage des immunoglobulines.

- C. La recherche et identification des IgE spécifiques.
 D. L'exploration de la fonction des lymphocytes T.
 E. La recherche des anticorps anti-nucléaires.
- 31) Le traitement par injection d'immunoglobulines par voie intraveineuse est indiqué dans :
 A. Le déficit en BTK. C. Le CVID. E. La maladie de Bruton
 B. Le déficit sélectif en IgA. D. Le Syndrome de Wiskott Aldrich
- 32) L'immunité anti-bactérienne fait intervenir les moyens de l'immunité innée suivantes :
 A. Les barrières cutané-muqueuses.
 B. Les lymphocytes T cytotoxiques.
 C. Le système du complément.
 D. Les cellules phagocytaires.
 E. Les immunoglobulines.
- 33) Parmi les moyens de défense contre les virus et les infections virales, on peut citer :
 A. La lyse des cellules phagocytaires.
 B. La cytotoxicité par le mécanisme d'ADCC.
 C. L'activation du complément par la voie classique.
 D. L'action des lymphocytes B cytotoxiques.
 E. La neutralisation des virus par les anticorps.
- 34) Pour une activité anti-infectieuse, Les cellules phagocytaires :
 A. Ont des récepteurs spécifiques pour les antigènes.
 B. Expriment des récepteurs qui permettent de reconnaître un grand nombre de pathogènes différents.
 C. Exercent la fonction de bactéricidie par l'action des perforines et granzymes.
 D. Synthétise les radicaux libres oxygénés qui sont de puissants agents bactéricides.
 E. Interviennent dans deuxième temps, après les lymphocytes T.
- 35) Les lymphocytes T Cytotoxiques sont plus efficaces :
 A. Contre les bactéries à multiplication extra-cellulaires.
 B. Contre les bactéries à multiplication intra-cellulaires.
 C. Après activation par les polynucléaires neutrophiles.
 D. Contre les infections virales.
 E. Contre les infections fongiques.
- 36) Les PNN, doivent avoir pour exercer convenablement leurs fonctions :
 A. L'expression en surface des récepteurs pour les molécules chimio-attractantes.
 B. La capacité de phagocyter les agents pathogènes.
 C. L'expression des récepteurs pour les pathogènes comme les TLR.
 D. Les moyens nécessaires pour la synthèse des radicaux libres oxygénés.
 E. L'expression des molécules HLA de classe II.
- 37) L'apparition d'infections à répétition dues essentiellement à des germes à multiplication extracellulaires chez une fille de 6 ans peut être en faveur à quel type de déficit immunitaire, parmi les suivants :
 A. Granulomatose septique chronique. C. L'Ataxie-Télangiectasie.
 B. Hypogammaglobulinémies Communes à expression Variable. D. Déficit en CD132. E. Déficit en ADA.
- 38) Dans l'hypersensibilité typell, l'antigène déclenchant peut être : (Indiquer la ou les Réponses INEXACTES)
 A. Un auto-antigène tels que les récepteurs cellulaires
 B. Un antigène de soi sous forme de complexe immun
 C. Des protéines exogènes appartenant à des microorganismes
 D. Un haptène tel qu'un médicament (exemple : Pénicilline)
 E. Un allo-antigène telles que les molécules HLA
- 39) Concernant le rejet hyper aigue au cours de la greffe rénale :
 A. Il survient toujours lors d'une immunisation vis-à-vis des antigènes du donneur
 B. Est prévenu par la recherche d'anticorps anti HLA
 C. A bases immunologiques
 D. Est détecté par un cross match positif E. Il peut survenir suite à une transfusion sanguine
- 40) Lors de la transplantation rénale :
 A. Une compatibilité génétique entre D et R s'accompagne d'une probabilité de rejet faible ou nulle (cas d'allogreffe)
 B. Une incompatibilité importante s'accompagne d'une probabilité de rejet élevée (cas de la xénogreffe).
 C. Il est nécessaire que le D et le R soit HLA semi-identique
 D. Il est nécessaire que le D et le R soit HLA identique E. Soit de groupages ABO incompatible

Corriger Type

FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE

DEPARTEMENT D

3^{ème} Année de Médecine .Le 19/03/2025

EMD D'IMMUNOLOGIE (40 QCM)

Cocher la ou les propositions exactes

(Durée

- 1) Pour doser un antigène « X » par une technique immuno-enzymatique par compétition, On peut :
- ☒ A. Spectrophotomètre.
 - ☐ B. Des Anticorps anti-X marqués par une enzyme.
 - ☐ C. Des solutions étalons contenant des concentrations connues d'Ac anti-X.
 - ☒ D. Des Anticorps anti-X fixés sur la microplaque.
 - ☒ E. Des antigènes X marqués par une enzyme.
- 2) Le système Streptavidine- Biotine :
- ☐ A. Augmente la sensibilité des techniques d'immunofluorescence.
 - ☐ B. La Streptavidine est une vitamine et la biotine est une protéine microbienne.
 - ☒ C. La Streptavidine peut fixer 4 molécules de biotine.
 - ☐ D. On marque l'Ac ou l'Ag avec la biotine et on couple l'enzyme avec la streptavidine.
 - ☒ E. Est un système d'amplification du signal des techniques immuno-enzymatiques.
- 3) L'Hypersensibilité :
- ☒ A. Peut être allergique ou non allergique.
 - ☒ B. Sont des signes cliniques objectivement reproductibles.
 - ☐ C. Quand elle est allergique le mécanisme peut être non immunologique.
 - ☐ D. L'hypersensibilité allergique est médiée uniquement par les IgE.
 - ☐ E. L'Hypersensibilité Allergique atopique peut être médiée par les IgG.
- 4) Dans l'hypersensibilité type I :
- ☒ A. Le récepteur RFc ϵ 1 est composé de 4 chaînes polypeptidiques.
 - ☒ B. Les cellules TH2 sécrètent IL-4 et IL-13.
 - ☐ C. L'activation des mastocytes a lieu lors de la phase de sensibilisation.
 - ☐ D. L'activation déclenche deux types de réponses dans le mastocyte.
 - ☒ E. La libération de médiateurs préformés tels que l'histamine
- 5) Dans la réaction de type II, quel est l'effet des anticorps anti-récepteurs sur les cellules cibles ?
- ☒ A. Effet antagoniste des anti-IgG sur les récepteurs de l'acétylcholine dans la Myasthénie
 - ☐ B. Activation de la prolifération cellulaire
 - ☒ C. Effet agoniste des anti-IgG sur les récepteurs de la TSH dans Maladie de Basedow
 - ☐ D. Déclenchement de l'inflammation
 - ☐ E. Toutes les réponses sont justes
- 6) L'immunofixation :
- ☒ A. Permet de mettre en évidence un composant monoclonal.
 - ☐ B. Ne permet pas de mettre en évidence un composant monoclonal.
 - ☐ C. Permet de comparer les protéines sériques d'un patient avec un sérum témoin.
 - ☒ D. Ne permet pas de comparer les protéines sériques d'un patient avec un sérum témoin.
 - ☐ E. Contrairement à l'immunoélectrophorèse, elle est réalisée en un seul temps.
- 7) Le Mancini qualitatif :
- ☐ A. Nécessite l'utilisation d'une courbe d'étalonnage.
 - ☒ B. Ne nécessite pas l'utilisation d'une courbe d'étalonnage.
 - ☒ C. Nécessite toujours l'incorporation de l'anticorps dans la gélose.
 - ☐ D. Ne nécessite pas toujours l'incorporation de l'anticorps dans la gélose.
 - ☐ E. Utilise comme le Laurell un champ électrique.
- 8) Dans la dermatite de contact allergique, le TNF- α intervient :
- ☒ A. Au cours de la phase de sensibilisation
 - ☒ B. Au cours de la phase de déclenchement
 - ☐ C. Dans la différenciation des TCD4⁺ en Th1
 - ☐ D. Dans l'activation des macrophages
 - ☐ E. Dans l'activation des LT cytotoxiques
- 9) Concernant l'incompatibilité fœto-maternelle dans le système Rhésus
- ☒ A. Elle survient chez une mère Rh- portant un fœtus Rh+
 - ☐ B. Le Coombs direct permet de détecter la présence d'anticorps dirigés contre les GR maternels

- ☒ C. Dans le Coombs indirect, un résultat positif indique que la mère a des Ac anti-Rh, augmente
- ☒ D. Peut provoquer une hyperbilirubinémie chez le nouveau-né
- ☒ E. Les IgG anti-Rh passent à travers le placenta, entraînant une érythroblastose fœtale.
- 10) Les anticorps anti-Sm :
- ☒ A. Sont dirigés contre des antigènes nucléaires. *Contre le noyau.*
- B. Sont dirigés contre des antigènes cytoplasmiques.
- ☒ C. Peuvent être retrouvés dans le lupus érythémateux disséminé.
- D. Ne sont jamais retrouvés dans le lupus érythémateux disséminé.
- ☒ E. Sont des anticorps non spécifiques d'organes.
- 11) Les anticorps anti-globules rouges :
- ☒ A. Entraînent une anémie hémolytique.
- B. Sont mis en évidence uniquement par le test de Coombs direct.
- C. Sont mis en évidence uniquement par le test de Coombs indirect.
- ☒ D. Peuvent être mis en évidence par les tests de Coombs direct et indirect.
- ☒ E. Peuvent être retrouvés dans le lupus érythémateux disséminé.
- 12) Les techniques de chimiluminescence :
- A. Produisent une fluorescence suite à une réaction chimique.
- B. Le prototype est le test Farr.
- ☒ C. L'émission lumineuse peut provenir d'une molécule transformée par une enzyme.
- ☒ D. Se caractérisent uniquement par un spectre d'émission.
- E. La lecture se fait par un spectrophotomètre.
- 13) L'Anaphylaxie :
- ☒ A. Est une Réaction d'hypersensibilité systémique sévère.
- ☒ B. Le traitement consiste en l'administration rapide d'Adrénaline.
- ☒ C. En cas d'atteinte hémodynamique on parle de choc anaphylactique.
- D. L'Allergène est toujours injectable.
- E. Est une réaction d'Hypersensibilité type II.
- 14) Ces antigènes peuvent donner des réactions retardées granulomateuses :
- A. Dérivés microbiens
- C. Allo-antigènes
- ☒ B. Germes
- ☒ D. Métaux
- ☒ E. Particules
- 15) L'objectif de l'utilisation de l'intradermoréaction comme outil diagnostique est :
- A. L'induction d'une réponse immunitaire primaire
- B. La désensibilisation vis-à-vis d'un antigène donné
- ☒ C. La réactivation des lymphocytes mémoires
- ☒ D. La détection des sujets pré-sensibilisés vis-à-vis de l'antigène utilisé
- E. La détection de l'allergène causal
- 16) Les facteurs qui influencent le lieu de dépôt des complexes immuns sont :
- ☒ A. Leur taille
- ☒ C. L'inflammation
- ☒ B. Leur charge électrique
- D. Leur quantité
- E. Toutes
- 17) La réaction d'agglutination active indirecte:
- ☒ A. L'Ag est particulaire et fait partie intégrante de la particule.
- B. L'Ag est soluble et rendu particulaire par sa fixation sur une particule.
- C. L'Ac est agglutinant.
- ☒ D. L'Ac est précipitant est rendu agglutinant par sa fixation sur une particule.
- E. Est appelée également test direct à l'antiglobuline.
- 18) L'épreuve de Beth Vincent :
- ☒ A. Est aussi appelée épreuve globulaire directe.
- B. Est aussi appelée épreuve globulaire indirecte.
- ☒ C. Permet de tester les globules rouges d'un sujet vis-à-vis d'anticorps sériques connus.
- D. Permet de tester le sérum d'un sujet vis-à-vis de globules rouges connus.
- E. Est appelée également épreuve de Simonin.
- 19) Les anticorps monoclonaux chimériques :
- ☒ A. Sont constitués d'une partie constante humaine et d'une partie variable murine.
- B. Sont constitués d'une partie constante murine et d'une partie variable humaine.
- C. Sont très immunogènes.

- ☒ D. Sont peu immunogènes.
E. Ne sont pas immunogènes.
- 20) L'inflammation dans l'HS de type III est le résultat de l'activation :
- ☒ A. Du système du complément
☒ B. Des macrophages
C. Des polynucléaires neutrophiles
D. Des polynucléaires éosinophiles
- 21) Pour donner des réactions de type Arthus, l'antigène doit :
- A. Traverser l'épiderme
B. Se coupler aux antigènes endogènes
C. Passer dans la circulation sanguine
☒ D. Rester dans le site d'introduction
☒ E. Stimuler une réponse humorale spécifique à IgG
- 22) Les anticorps anti-récepteur de la TSH :
- ☒ A. Sont des anticorps antithyroïdiens.
B. Ne sont pas des anticorps antithyroïdiens.
☒ C. Sont spécifiques d'organes.
D. Ne sont pas spécifiques d'organes.
E. Ne sont jamais retrouvés dans le basedow.
- 23) La sélection positive :
- A. Concerne uniquement les lymphocytes T.
B. Concerne uniquement les lymphocytes B.
☒ C. Concerne les lymphocytes T et B.
☒ D. A lieu au niveau des organes lymphoïdes centraux.
E. A lieu au niveau des organes lymphoïdes périphériques.
- 24) Les vaccins :
- ☒ A. Font partie de l'immunothérapie active.
B. Font partie de l'immunothérapie passive.
C. Sont utilisés uniquement à visée prophylactique.
☒ D. Peuvent être utilisés à visée thérapeutique.
E. Procurent un effet rapide mais éphémère.
- 25) La présence d'un clone plasmocytaire malin est détectée dans la moelle osseuse de patient :
- ☒ A. La maladie de Kahler
B. Les MGUS-non IgM
C. La maladie de Waldenström
☒ D. Le myélome indolent
E. L.
- 26) La mise en évidence de l'IgM monoclonale dans le sérum :
- A. Permet d'éliminer le diagnostic d'une maladie de Kahler
B. Est suffisante pour poser le diagnostic d'une maladie de Waldenström.
C. Se traduit par l'apparition d'une ligne supplémentaire à l'immunoselection
☒ D. Nécessite l'utilisation d'une technique électrophorétique couplée à une technique de
E. N'est pas nécessaire si le clone lymphoplasmocytaire est mis en évidence sur une bi
- 27) L'immunoglobulinopathie la moins fréquente parmi celles citées ci-dessous :
- A. Myélome multiple
B. MGUS-IgM
C. MGUS-non IgM
D. Maladie de Waldenström
☒ E. M
- 28) Le syndrome de DI GEORGE est :
- A. Un déficit qui touche principalement l'immunité humorale.
B. Due à une mutation d'un gène situé sur le chromosome X.
☒ C. Un déficit immunitaire combiné.
D. Un déficit T- B- NK-.
E. Un déficit dont le traitement est basé sur l'injection d'immunoglobulines polyvalentes
- 29) Le déficit en BTK est suspecté devant :
- A. Un malade de sexe féminin.
☒ B. La présence d'infection à répétition de localisation muqueuses.
C. La présence d'une hypergammaglobulinémie à l'électrophorèse des protéines sériques.
D. Un nombre normal des lymphocytes B au niveau de la circulation sanguine.
E. L'apparition d'infections à répétition dès les premières semaines après la naissance.
- 30) Parmi les moyens utilisés pour explorer un déficit immunitaire, on peut citer :
- ☒ A. L'électrophorèse des protéines sériques.
☒ B. Le dosage des immunoglobulines.

C. La recherche et identification des IgE spécifiques.

☒ D. L'exploration de la fonction des lymphocytes T.

E. La recherche des anticorps anti-nucléaires.

31) Le traitement par injection d'immunoglobulines par voie intraveineuse est indiqué dans :

☒ A. Le déficit en BTK.

☒ C. Le CVID.

☒ E. La ma

B. Le déficit sélectif en IgA.

D. Le Syndrome de Wiskott Aldrich

32) L'immunité anti-bactérienne fait intervenir les moyens de l'immunité Innée suivantes :

☒ A. Les barrières cutané-muqueuses.

B. Les lymphocytes T cytotoxiques.

☒ C. Le système du complément.

☒ D. Les cellules phagocytaires.

E. Les Immunoglobulines.

33) Parmi les moyens de défense contre les virus et les infections virales, on peut citer :

A. La lyse des cellules phagocytaires.

☒ B. La cytotoxicité par le mécanisme d'ADCC.

☒ C. L'activation du complément par la voie classique.

D. L'action des lymphocytes B cytotoxiques.

☒ E. La neutralisation des virus par les anticorps.

34) Pour une activité anti-infectieuse, Les cellules phagocytaires :

A. Ont des récepteurs spécifiques pour les antigènes.

☒ B. Expriment des récepteurs qui permettent de reconnaître un grand nombre de pathogènes différenciés.

C. Exercent la fonction de bactéricide par l'action des perforines et granzymes.

☒ D. Synthétise les radicaux libres oxygénés qui sont de puissants agents bactéricides.

E. Interviennent dans deuxième temps, après les lymphocytes T.

35) Les lymphocytes T Cytotoxiques sont plus efficaces :

A. Contre les bactéries à multiplication extra-cellulaires.

☒ B. Contre les bactéries à multiplication intra-cellulaires.

C. Après activation par les polynucléaires neutrophiles.

☒ D. Contre les infections virales.

E. Contre les infections fongiques.

36) Les PNN, doivent avoir pour exercer convenablement leurs fonctions :

☒ A. L'expression en surface des récepteurs pour les molécules chimio-attractantes.

☒ B. La capacité de phagocyter les agents pathogènes.

☒ C. L'expression des récepteurs pour les pathogènes comme les TLR.

☒ D. Les moyens nécessaires pour la synthèse des radicaux libres oxygénés.

E. L'expression des molécules HLA de classe II.

37) L'apparition d'infections à répétition dues essentiellement à des germes à multiplication extracellulaires c

6 ans peut être en faveur à quel type de déficit immunitaire, parmi les suivants :

A. Granulomatose septique chronique.

C. L'Ataxie-Télangiectasie.

☒ B. Hypogammaglobulinémies Communes à expression Variable.

D. Déficit en CD132.

E.

38) Dans l'hypersensibilité typell, l'antigène déclenchant peut être : (Indiquer la ou les Réponses INEXACTES)

A. Un auto-antigène tels que les récepteurs cellulaires

☒ B. Un antigène de soi sous forme de complexe Immun

☒ C. Des protéines exogènes appartenant à des microorganismes

D. Un haptène tel qu'un médicament (exemple : Pénicilline)

E. Un allo-antigène telles que les molécules HLA

39) Concernant le rejet hyper algue au cours de la greffe rénale :

☒ A. Il survient toujours lors d'une immunisation vis-à-vis des antigènes du donneur

☒ B. Est prévenu par la recherche d'anticorps anti HLA

☒ C. A bases Immunologiques

☒ D. Est détecté par un cross match positif

E. Il peut survenir suite à une transfusion

40) Lors de la transplantation rénale :

A. Une compatibilité génétique entre D et R s'accompagne d'une probabilité de rejet faible ou nulle (cas de la xénogreffe).

☒ B. Une incompatibilité importante s'accompagne d'une probabilité de rejet élevée (cas de la xénogreffe).

☒ C. Il est nécessaire que le D et le R soit HLA semi-identique

☒ D. Il est nécessaire que le D et le R soit HLA identique

E. Soit de groupages ABO incompatibles

Il est nécessaire que le D et le R

Dr. SEBTE
Maître Ass
en Immuno